

急诊出院小结（中文翻译）——含血液检查

悉尼皇家阿尔弗雷德王子医院（Royal Prince Alfred Hospital, RPA）急诊科 · 就诊日期：2026年8月24日 · 文书：ED Discharge Referral（最终报告），签发医生 Dr Mitchell Crebert（急诊住院医师）

【非官方翻译，仅供参考 —— 英文原件（照片版）随附。翻译日期：2026-08-31。】患者：Yujie CAO，女，29岁，病历号 MRN 298-22-60。

诊断

脊髓脂肪瘤（Lipoma of spinal cord）（出院诊断）

病程摘要（原文直译）

Yujie CAO，29岁女性，于2026年8月24日就诊于皇家阿尔弗雷德王子医院急诊科。就诊原因为门诊MRI发现一巨大脊柱脂肪瘤在L5水平压迫脊髓。**查体见：左下肢整体运动功能减退；肛门括约肌张力减低；鞍区感觉异常。**已请神经外科会诊，会诊要求行**腰椎CT，证实该脂肪瘤。**评估后准予出院。

出院计划（原文直译）

- 出院回家。
- 神经外科团队将在约4-6周内联系患者，安排神经外科门诊。
- 数日内复诊全科医生；由全科医生转诊并确保完成尿动力学检查——已嘱患者携带结果赴神经外科门诊。（注：尿动力学已于2025年10月8日完成，报告随附。）
- 如有不适或严重情况，请返回急诊。

过敏史：无已知过敏（NKA）。出院带药：无。

血液检查（2026-08-24 15:40，RPA）

项目	结果	项目	结果
钠	139 mmol/L	血红蛋白 Hb	133 g/L
钾	4.1 mmol/L	血小板 PLT	314 ×10 ⁹ /L
氯	101 mmol/L	红细胞压积 PCV	0.41 L/L
碳酸氢盐	26 mmol/L	平均红细胞体积 MCV	88 fL
尿素	4.8 mmol/L	红细胞计数 RCC	4.70 ×10 ¹² /L
肌酐	82 μmol/L	MCH / MCHC	28.4 pg / 324 g/L
估算肾小球滤过率 eGFR	84 mL/min/1.73m ²	RDW	13.4 %
总胆红素	9 μmol/L	白细胞 WCC	7.7 ×10 ⁹ /L
白蛋白	43 g/L	中性粒细胞	4.2 ×10 ⁹ /L
总蛋白	78 g/L	淋巴细胞	2.8 ×10 ⁹ /L
碱性磷酸酶 ALP	44 U/L	单核细胞	0.5 ×10 ⁹ /L
γ-谷氨酰转移酶 GGT	9 U/L	嗜酸/嗜碱粒细胞	0.1 / 0.1 ×10 ⁹ /L
丙氨酸转氨酶 ALT	16 U/L	凝血酶原时间 PT	11.6 秒
天冬氨酸转氨酶 AST	21 U/L	APTT	35 秒
钙 / 校正钙	2.37 / 2.31 mmol/L	INR	1.1
镁	0.91 mmol/L	血型	B 型，Rh 阳性
磷	1.16 mmol/L	红细胞抗体筛查	阴性
C反应蛋白 CRP	<0.3 mg/L	血涂片	未复核

要点（患者方注，非报告内容）

- 凝血功能正常、血型鉴定+抗体筛查已完成（**B型Rh阳性、抗体阴性**）——术前备血信息已具备。
- CRP <0.3、血常规正常 —— 皮毛窦目前**无感染征象**。
- eGFR 84 对29岁而言略低（肌酐82，正常上限附近）——结合残余尿300ml的神经源性膀胱背景，建议作为基线随访。